

24 - L'Échec Scolaire - Pr. AABBASSI

(0:02 - 0:24)

Bonjour, nous allons traiter ensemble aujourd'hui l'échec scolaire. Au terme de ce cours, vous serez capables de définir l'échec scolaire, de connaître les causes de l'échec scolaire, d'évaluer cliniquement un enfant en situation d'échec scolaire et d'orienter sa prise en charge. Nous allons suivre le plan suivant.

(0:27 - 1:01)

L'échec scolaire se définit comme un enfant qui ne réussit pas à l'école ou qui réussit avec plus de difficultés que les autres enfants ou qui n'arrive pas à s'intégrer en communauté scolaire en raison de ses difficultés comportementales, psycho-affectives ou relationnelles. L'échec scolaire est semblable aussi au retard scolaire, aux difficultés scolaires, au rejet scolaire et au décrochage scolaire. C'est une demande qui se voit croissante, avec ses avis éducatifs, psychologiques et médicaux.

(1:03 - 1:20)

Il met en jeu de façon durable le statut scolaire, social, émotionnel de l'enfant. Qu'en est-il de l'épidémiologie ? C'est un motif fréquent de consultation. Ça touche 15 à 20 % des enfants scolarisés.

(1:22 - 1:47)

Dans notre Faculté de médecine de pharmacie de Marrakech en 2009, une thèse en médecine générale a été réalisée qui a recensé 100 cas d'écoliers en situation d'échec scolaire âgés entre 6 et 12 ans qui ont été suivis en consultation de pédopsychiatrie à l'hôpital militaire Avicenne de Marrakech sur une durée de 5 ans. La moyenne de l'âge de nos écoliers était de 8,9 ans. Et ça touchait deux garçons pour une fille.

(1:51 - 2:36)

Quelles sont les causes de l'échec scolaire ? Apprendre et réussir dépendent de plusieurs facteurs. Des facteurs individuels, de l'ordre de la motivation, l'envie, le capital cognitif, l'intelligence, les moyens spécifiques des apprentissages comme la mémoire, l'attention, des facteurs sociaux et environnementaux, par exemple, le niveau socio-économique des parents, le niveau éducatif des parents, la proximité de l'école et des facteurs éducatifs et pédagogiques, c'est-à-dire, la stratégie d'apprentissage que suit l'école, la disponibilité de l'éducateur. Tous ces facteurs vont se conjuguer pour permettre à l'enfant d'apprendre et de réussir.

(2:39 - 3:28)

Quelles sont les causes de l'échec scolaire ? Il y a des causes individuelles comme des maladies organiques, des épilepsies ou crises très fréquentes, la surdité, l'hypoacousie, les troubles visuels, le diabète mal équilibré, la migraine, les maladies génétiques ou toute autre maladie organique qui peut être cause d'un absentéisme ou d'une irrégularité. Les difficultés intellectuelles, la déficience mentale, l'enfant précoce, les troubles spécifiques des apprentissages que nous appelons les enfants 10 et qu'on va voir en détail par la suite. Les difficultés comportementales, un enfant hyperactif, un enfant turbulent qui ne se concentre pas à l'école auraient bien évidemment des difficultés des apprentissages, la consommation d'alcool et de drogue, les troubles de comportement de l'adolescence.

(3:28 - 4:09)

Et les difficultés émotionnelles comme les dépressions, le refus scolaire anxieux appelé anciennement la phobie scolaire, l'anxiété de performance, l'anxiété de séparation et autres troubles psychiatriques. Les causes environnementales comme un divorce parental créant une situation d'instabilité et qui peut toucher l'enfant dans sa capacité de concentration, la pauvreté, l'analphabétisme des parents ou les niveaux d'instruction bas ou l'alcoolisme des parents qui peuvent être parfois violents et maltraitants envers l'enfant, un enfant maltraité et un enfant qui ne peut pas se concentrer à l'école. Les causes pédagogiques comme l'irrégularité et l'absentéisme en école.

(4:10 - 4:40)

Dans ce cours de pédopsychiatrie, nous allons traiter surtout les causes individuelles de l'ordre des difficultés intellectuelles, des difficultés comportementales et les difficultés émotionnelles. Les difficultés intellectuelles La déficience intellectuelle Sachez que c'est la crainte secrète des parents. Dans la tête des parents, le principal souci c'est de définir le quotient intellectuel de l'enfant et de savoir est-ce qu'il est intelligent ou pas intelligent.

(4:40 - 5:14)

La déficience intellectuelle se définit comme étant un état caractérisé par un quotient intellectuel le QI inférieur à 70 et un comportement adaptatif déficitaire qui se manifeste avant l'âge de 18 ans. Comportement adaptatif déficitaire veut dire que cet enfant n'est pas autonome pour ses soins ou pour ses apprentissages. Ces enfants ont des défauts dans la capacité à traiter les concepts, les opérations et autres données et ça va de soi qu'ils vont apprendre avec beaucoup de mal que les autres enfants de leur âge.

(5:15 - 5:54)

Il y a trois degrés de déficience qui s'accompagnent presque tous de difficultés scolaires. Il y a la déficience intellectuelle légère, la déficience intellectuelle moyenne et la déficience intellectuelle sévère. La précocité intellectuelle ou l'enfant précoce C'est un enfant dans l'âge mental de 2 à 7

ans en avance sur son âge réel, c'est à dire un QI supérieur à 125 généralement entre 125 et 130, ça touche 2,3 de chaque classe d'âge donc ils sont assez fréquents.

(5:54 - 6:16)

Un peu curieux de savoir que les enfants précoces qui ont un QI très supérieur auront de l'échec scolaire. Ils auront des difficultés d'apprentissage parce qu'il y a un décalage entre la maturité intellectuelle et la maturité affective. C'est à dire, ce sont des enfants qu'on appelle adultes formes qui ont un comportement d'adulte.

(6:17 - 6:59)

Ils vont s'ennuyer, ils vont être démotivés parce qu'ils connaissent déjà les réponses et de ce cas, ils ne vont pas investir les exercices et les apprentissages. Ils peuvent manifester difficultés face à l'effort, ils ont un manque de méthode, ils ont des préoccupations anxio-dépressives ou ils ont des stratégies spécifiques qui parfois ne sont pas fonctionnelles pour résoudre les exercices. Les troubles spécifiques des apprentissages ou les enfants 10 Ce sont des troubles assez fréquents touchant 5 à 6% d'enfants et donc, soit un enfant par classe.

(7:00 - 7:26)

Il s'agit de troubles permanents, envahissants et durables, dont l'origine est développementale, c'est à dire qu'ils sont présents tout le temps depuis le début des apprentissages. Ils vont affecter un ou plusieurs types d'apprentissages. Lorsque ça touche le langage écrit de l'ordre de la lecture qui est lente, qui est défectueuse ou qui est l'enfant qui va lire avec beaucoup de difficultés, c'est la dyslexie.

(7:26 - 7:54)

Lorsque ça touche l'orthographe, c'est à dire que l'enfant ne peut pas copier correctement, il est lent ou lors des moments de dicter son orthographe, il est défectueuse, on parle de dysorthographe. Lorsque ça touche les compétences arithmétiques et les habilités numériques, on parle de dyscalculie. Lorsque ça touche les aptitudes de planification, c'est la dyspraxie et de la préprogrammation des gestes complexes, notamment le geste graphique, c'est la dysgraphie.

(7:55 - 8:21)

On peut trouver plusieurs troubles dys associés. Par exemple, la dyslexie s'associe souvent à une dysorthographe, à une dyspraxie. Ils sont à différencier des troubles isolés et fonctionnels comme les retards simples dans le cadre de variations de la normale sans autre anomalie n'ayant décendance significative dans la famille.

(8:21 - 8:55)

Par exemple, un retard simple de l'acquisition de la lecture. Ils sont à différencier aussi des troubles associés ou secondaires à des carences socio-culturelles, éducatives et affectives, des événements familiaux ou scolaires, une déficience intellectuelle, des déficits sensoriels, des troubles psychiques ou des maladies somatiques. C'est-à-dire que les troubles spécifiques des apprentissages ou les enfants disent qu'ils ont un QI tout à fait normal, sans association à une autre pathologie, qu'elle soit retard mental, pathologie neurologique ou pathologie psychiatrique.

(8:59 - 9:29)

Les difficultés comportementales Le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité communément appelé le TDAH. Il s'agit d'un déficit attentionnel avec impossibilité de maintenir son attention sur une activité ou de finir ce qu'il a commencé, avec une agitation motrice et une incapacité à se tenir en place. L'impulsivité est là, donnant une incapacité à attendre son tour et recherche une relation exclusive avec l'adulte.

(9:30 - 11:21)

Ces enfants, ils ont dans 63% un besoin de soutien scolaire, ils redoublent dans 34%, et 20% ils sont intégrés en classes spécialisées et 17% des enfants ont des troubles de lecture. Lorsque vous diagnostiquez un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, il est impératif de chercher la présence de difficultés des apprentissages. Les troubles de comportement à l'adolescence qui peuvent être dus à des maladies psychiatriques comme la schizophrénie, les troubles bipolaires de l'humeur, ou l'anorexie mentale, ou à des consommations de drogues et d'alcool, ou des difficultés d'adaptation, c'est-à-dire qu'un adolescent qui est victime d'harcèlement scolaire, l'élève boucmissaire, ou qui a des conflits avec les parents, avec les éducateurs, ou avec ses amis, ses camarades de classe, va investir moins l'école et donc il aura une situation de décrochage scolaire.

Les difficultés émotionnelles. La dépression touche environ 16% des jeunes. C'est la première cause de décrochage scolaire.

Par la démotivation qu'il cause, par les difficultés de concentration et de mémorisation, par le sentiment d'impuissance, par la baisse ou la perte de l'estime de soi. Et donc l'enfant déprimé, ou l'adolescent déprimé, investit moins l'école, il s'ennuie, et il se voit incapable de résoudre les solutions, ou de répondre aux questions, et donc il aura un échec scolaire, ou des difficultés scolaires. Les états anxieux sont aussi réputés comme causes intéressantes et importantes à chercher de difficultés scolaires.

(11:21 - 11:42)

Ce sont des états affectifs dans lesquels le sujet a le sentiment d'un danger indéterminé, devant lequel il est en position d'attente. Il se sent incapable de se défendre. Les troubles anxieux qui peuvent s'accompagner d'échecs scolaires sont l'anxiété de séparation, le trouble panique, le

refus scolaire anxieux.

(11:43 - 12:16)

Ce sont des jeunes, enfants ou adolescents, qui ne vont pas à l'école et qui préfèrent rester à la maison. Il y a aussi des troubles anxieux généralisés, il y a la phobie sociale, et donc il ne peut pas prendre la parole, il ne peut pas répondre aux questions, les phobies spécifiques et les agoraphobies. Le refus scolaire anxieux est le trouble anxieux le plus fréquent chez l'enfant, et celui qui donne le plus des situations de décrochage scolaire.

(12:16 - 12:47)

Ce sont des enfants, en général des filles, qui pour des raisons irrationnelles refusent d'aller en classe et résistent avec des réactions d'angoisse voire de panique. Lors des changements de scolarité par exemple, le passage de la maternelle aux primaires ou du primaire aux secondaires, mais surtout à l'émergence de l'adolescence. Ce sont des enfants qui ont une dynamique familiale assez particulière, un papa qui est absent ou inaccessible, un lien d'hyper-protection et d'hyper-dépendance avec la maman, et l'enfant.

(12:51 - 13:08)

L'anxiété de performance est une forme intéressante de troubles anxieux chez l'enfant. L'anxiété est liée aux situations d'évaluation. Elle implique des signes et des symptômes parfois somatiques, surtout, variés dans le stress, la peur, dans la peur de l'échec et la détresse.

(13:09 - 13:20)

Face à l'évaluation, l'élève a un sentiment d'angoisse et d'anxiété ou de peur. Il a par ainsi des difficultés à se concentrer et à y réfléchir. Il a des troubles de l'attention.

(13:20 - 13:38)

Il se pose des exigences qui sont trop élevées par rapport à son niveau. Il a des difficultés à profiter du moment présent. Il a des préoccupations excessives pour les résultats et aussi pour l'évaluation qui va se manifester à la veille des évaluations par des signes somatiques ou par des troubles de sommeil.

(13:39 - 14:36)

Il a tendance à s'attribuer de façon très exagérée les échecs et à l'extérieur ou la chance les réussit. Attention à une notion importante qui est la spirale psychopathologique de l'échec. C'est-à-dire qu'une cause de l'échec scolaire peut engendrer une autre.

Par exemple, la cause organique d'épilepsie peut donner des troubles de comportement et lorsque cet enfant va se trouver différent des autres, il peut avoir des réactions anxieuses et

dépressives et donc on peut avoir aussi une cause émotionnelle qui va se rajouter. Donc échec scolaire, cause organique peut donner une cause comportementale, peut donner une cause émotionnelle et la cause intellectuelle par des difficultés de concentration. Un autre exemple de la spirale psychopathologique de l'échec sont les troubles d'IS.

(14:37 - 16:22)

Les troubles d'IS, qu'ils soient dysphasie, dyslexie, dyspraxie, déficit d'attention, vont donner un échec scolaire. L'échec scolaire va donner la baisse de l'estime de soi et les conflits avec l'environnement et donc il va générer une cause émotionnelle qui est la dépression. La dépression peut elle-même donner un syndrome d'échec, un désinvestissement, une anxiété de performance et l'enfant, il devient irritable et violent ou il va se replier sur soi-même, il va être en retrait et donc on a une cause comportementale et ainsi de suite, on tombe dans la spirale.

Comment évaluer cliniquement une situation d'échec scolaire? Vous serez amené à recevoir ces demandes de la part des parents, quelles soient vos pratiques auprès des enfants. On commence par une anamnèse, on va accueillir les signes cliniques, on va retracer de façon minutieuse l'histoire scolaire depuis le pré-scolaire, la crèche et la maternelle, l'école primaire, est-ce que cet enfant, pendant son parcours, avait besoin d'aide ou de soutien scolaire? On va retracer l'histoire des difficultés, depuis combien de temps il se sent installé? Est-ce que l'expression est différente entre l'école ou à la maison? Est-ce que l'enfant ou l'adolescent se trouve à l'aise à faire ses exercices à la maison contrairement à l'école ou le contraire? Est-ce que l'enfant travaille-t-il seul ou est-il aidé par ses parents? On va préciser l'histoire développementale, les activités parascolaires, le fonctionnement global de l'enfant, la réaction des parents face aux difficultés. Tout cela va nous donner une idée sur l'enfant, sur son fonctionnement et sur le fonctionnement de l'enfant dans sa famille.

(16:25 - 16:53)

L'évaluation de l'enfant, c'est une évaluation globale. Face à vous, c'est un enfant que vous allez demander d'écrire. Vous allez évaluer la qualité de l'écriture et de la lecture.

Vous pouvez lui proposer des opérations de numération, aussi simple qu'elles soient. Vous pouvez lui demander de dessiner pour évaluer le geste graphique. Vous pouvez, à travers votre conversation, évaluer l'attention, la mémoire et l'intelligence.

(16:53 - 17:25)

Et bien évidemment, vous évaluez de façon psychoaffective la présence de signes en faveur, par exemple, d'une dépression ou d'une anxiété. Vous demandez à l'école les avis et les observations des instituteurs par des courriers et vous demandez aux parents les bulletins scolaires. Il y a des tests neuropsychologiques qui sont faits, tests d'intelligence et de concentration, qui est le WISC-R, qui va aussi définir le quotient intellectuel, ou des tests

attentionnels.

(17:26 - 17:46)

Le bilan orthophonique permet de préciser le niveau de développement de langage oral et de langage écrit. Le bilan psychomoteur permet une évaluation, par exemple, de la motricité fine, du geste graphique, des qualités attentionnelles de l'enfant. L'examen somatique doit être complet.

(17:47 - 18:08)

L'examen général, le poids et la taille qui sont rapportés aux courbes développementales. On recherche une dysmorphie qui peut nous orienter vers une maladie génétique qui peut être accompagnée de retards mentaux, par exemple. L'examen neurologique complet et sensoriel, nous avons vu que la surdité et les troubles visuels sont des causes de l'échec scolaire.

(18:09 - 19:04)

On peut demander des bilans paracliniques, comme des avis ORL, les avis ophtalmologiques, avis neuropédiatrique lorsqu'il y a des signes d'appel comme une dysmorphie ou une épilepsie, l'avis génétique avec le karyotype, garder à l'esprit que le syndrome de l'exo-fragile est un syndrome génétique qui touche les garçons et qui est accompagné de retards mentaux et qui est très fréquent, qu'il faudra chercher l'EEG et l'IRM cérébral s'il y a une indication. Maintenant comment prendre en charge ces enfants ? La prise en charge doit être précoce, plurielle autour de l'enfant, nous sommes à plusieurs autour de l'enfant, il y a les médecins, il y a les familles, il y a les psychologues, il y a les éducateurs, il y a les orthophonistes et les psychomotriciens. Premièrement, il y a les mesures rééducationnelles.

(19:06 - 20:01)

On peut recommander une rééducation orthophonique, du langage écrit, de la lecture, de l'orthographe et du calque, ou une rééducation psychomotrice pour améliorer la tension, la concentration, un travail sur la différenciation de la littéralité la droite et la gauche, lorsqu'il y a des difficultés d'intégration des repères spatio-temporels, pour travailler le geste graphique, c'est-à-dire la motricité fine, ou la coordination et la motricité globale. On peut spécifier la rééducation du geste graphique lorsqu'il y a une dysgraphie, la rééducation orthoptique, c'est-à-dire du champ visuel, voire sans indication en cas d'astigmatisme, de myopie ou de trouble du champ visuel. Les mesures pédagogiques, il faut toujours maintenir la scolarité quitte à l'aménager, même chez les enfants qui ont des déficiences intellectuelles, il faut toujours maintenir leur scolarité.

(20:01 - 20:46)

Les aménagements scolaires, c'est qu'on va informer l'école du type de difficultés, on va peut-être faire une réorientation scolaire, placer l'enfant en classe intégrée, demander aux parents une

aide à la vie scolaire, c'est-à-dire une éducatrice ou un éducateur qui va accompagner l'élève au quotidien en classe. On peut demander un tiers-temps supplémentaire, par exemple s'il a des difficultés d'attention ou il a une lenteur dans les réponses. Ou on peut mettre à disposition des outils scripteurs personnalisés, par exemple, chez les enfants dyslexiques, on peut autoriser l'utilisation de l'ordinateur au moment des évaluations.

(20:49 - 21:43)

Recommander le soutien scolaire, orienter vers un projet professionnel à l'adolescence et la remédiation cognitive peut trouver aussi sa place dans certains cas. Les soins pédopsychiatriques et psychologiques contiennent la psychothérapie individuelle de groupe et familiale, la médication en cas de troubles psychiatriques avérés, le mythylphénidate pour le trouble déficit de l'attention avec hyperactivité, les antidépresseurs pour la dépression et les troubles sanctueux ou les antihistaminiques pour les troubles de sommeil. La médication reste un traitement symptomatique qui n'est pas curatif et on prescrit généralement chez l'enfant les psychotropes, c'est-à-dire les médicaments indiqués en psychiatrie en cas d'échec des autres mesures que nous avons vu tout au long de ce chapitre de traitement.

(21:46 - 22:15)

La guidance parentale Nous allons aider ces parents qui sont généralement déroutés, désespérés et épuisés par des entretiens réguliers pour permettre d'exprimer la souffrance et faciliter l'évolution de l'enfant. On peut les aider par l'organisation du travail scolaire à la maison, le temps du travail scolaire qui ne doit pas empiéter sur des moments de plaisir, par exemple de jeux ou de sorties. L'enfant a le droit de jouer et de se reposer.

(22:16 - 22:41)

On peut les aider aussi par le fait de poser un cadre qui respecte les capacités de l'enfant. Ce n'est pas parce que je vais travailler beaucoup avec l'enfant qu'il va avoir de bonnes notes. Gardez à l'esprit que face à un enfant en difficulté scolaire, il faut éviter de le blâmer mais plutôt de le supporter dans ses efforts et ses réussites.

(22:41 - 23:31)

De lui dire qu'il devrait travailler plus est une erreur parce que déjà il travaille fort parce qu'il a honte. Il faut éviter de se fâcher parce que ce sont des enfants souvent très sensibles, avec une anxiété de performance. Il faudra plutôt les encourager et les soutenir dans leurs progrès, même les plus minimes.

En conclusion, l'échec scolaire est une souffrance terrible à la fois pour l'enfant que pour ses parents. Ça engage le statut scolaire social-émotionnel de l'enfant et il est dû à des causes multiples qu'il faudra retenir et rechercher activement. La prise en charge permet de repérer et

d'évaluer l'enfant précocement afin de le remettre sur la bonne voie des apprentissages.